PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROCESSO DE ENFERMAGEM E ATUAÇÃO DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA COLETA DE DADOS, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E REGISTROS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 8 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

8.1 Base legal

A **Lei nº 7.498/1986** (Lei do Exercício Profissional) e o **Decreto nº 94.406/1987** definem as atribuições da equipe. O técnico em enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e **participação no planejamento** da assistência, executando ações assistenciais, **exceto as privativas do enfermeiro**, sempre sob **supervisão** do enfermeiro.

São **privativos do enfermeiro**: direção e chefia do serviço de enfermagem; consulta de enfermagem; **prescrição da assistência de enfermagem**; cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida; cuidados de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos científicos e capacidade de tomar decisões imediatas; o **diagnóstico de enfermagem**.

8.2 Processo de Enfermagem (PE) – Resolução COFEN nº 736/2024

A Resolução COFEN nº 736/2024 (que revogou a 358/2009) dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em **todo contexto socioambiental** onde ocorre o cuidado de enfermagem. O PE é organizado em **cinco etapas** inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas:

Etapa	Descrição	Participação do técnico
1. Avaliação de Enfermagem	Coleta de dados subjetivos e objetivos (anamnese e exame físico)	**Participa** (dados, sinais vitais, observações)
2. Diagnóstico de Enfermagem	Interpretação e julgamento clínico dos dados	**Privativo do enfermeiro**
3. Planejamento de Enfermagem	Priorização dos diagnósticos, resultados esperados e **prescrição** de enfermagem	Participa do planejamento; a prescrição é **privativa do enfermeiro**
4. Implementação de Enfermagem	Execução das intervenções prescritas	**Executa**, sob supervisão
5. Evolução de Enfermagem	Avaliação dos resultados alcançados e revisão do plano	A evolução é do enfermeiro; o técnico faz as **anotações**

Na Resolução 358/2009 (revogada) as etapas eram: coleta de dados (histórico), diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. A **Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)** organiza o trabalho quanto a método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do PE.

Taxonomias mais usadas: **NANDA-I** (diagnósticos), **NIC** (intervenções), **NOC** (resultados) e **CIPE** (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem).

8.3 Registros e anotações de enfermagem

A **Resolução COFEN nº 545/2017** trata da **anotação** e do uso do número de inscrição: o profissional deve registrar, após a assinatura, a **categoria profissional abreviada** (Enf., TE ou AE) e o **número de inscrição no COREN**, ou usar carimbo. A **Resolução COFEN nº 429/2012** dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário, em meio **tradicional ou eletrônico**.

Anotação × Evolução:

Anotação de enfermagem	Evolução de enfermagem
Feita por toda a equipe (técnico, auxiliar e enfermeiro)	**Privativa do enfermeiro**
Registra dados pontuais e imediatos: o que foi observado e realizado	Análise reflexiva dos dados, com avaliação do estado do paciente nas últimas 24 h

Referente a um momento	Referente ao período, com comparação e planejamento

Características de uma boa anotação: legível, clara, objetiva, cronológica (com **data e hora**), completa, sem rasuras, **sem espaços em branco**, sem abreviaturas não padronizadas, com terminologia técnica, escrita a caneta (preferencialmente azul ou preta conforme a instituição), registrada **imediatamente após** o cuidado e nunca antes, assinada e carimbada. Em caso de erro, não usar corretivo: escrever "**digo**" ou "**em tempo**" e corrigir (ou riscar com um traço simples que mantenha legível o texto original).

Exemplo de anotação: "08h00 – Paciente em leito, consciente, orientado, deambulando sem auxílio. Aceitou dieta oral oferecida. Refere dor em região abdominal, intensidade 6/10. Comunicado enfermeiro. SSVV: PA 130 × 80 mmHg, FC 88 bpm, FR 18 irpm, T 36,5 °C. Diurese espontânea, coloração amarelo-clara. – Maria Silva, TE, COREN-TO 000000."

O prontuário é **documento legal** e de propriedade do paciente (sob guarda da instituição); deve ser mantido por **no mínimo 20 anos** a partir do último registro (Lei nº 13.787/2018 – prontuário digitalizado). O acesso de terceiros depende de autorização do paciente ou ordem judicial.

8.4 Admissão, transferência e alta

- **Admissão:** recepção, identificação (pulseira), orientação sobre a unidade e rotinas, verificação de SSVV, peso e altura, guarda de pertences com relação assinada e registro.
- **Transferência:** comunicação com a unidade de destino, preparo do prontuário, transporte seguro e registro do horário e das condições.
- **Alta:** orientações (medicamentos, retorno, sinais de alerta), devolução de pertences, retirada de dispositivos conforme prescrição e registro das condições de saída.
- **Óbito:** constatação e atestado são atos médicos; a enfermagem realiza o preparo do corpo, identificação, guarda de pertences e registro.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Etapas do PE segundo a Resolução COFEN 736/2024.
- Diagnóstico e prescrição de enfermagem são privativos do enfermeiro.
- O técnico participa da coleta de dados, do planejamento e executa a implementação.
- Anotação (toda a equipe) × evolução (enfermeiro).
- Resolução COFEN 545/2017: categoria abreviada + número do COREN.
- Características da anotação: data, hora, sem rasuras, "digo"/"em tempo".
- Prontuário guardado por 20 anos.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"ADPIE"**: Avaliação, Diagnóstico, Planejamento, Implementação, Evolução (736/2024).
- **"Diagnóstico e prescrição: só com o enfermeiro"**.
- **"Anota quem faz, evolui quem é enfermeiro"**.
- **"Errou? Digo!"**: nunca corretivo nem rasura.
- **"Não anote o que não fez; não faça sem anotar"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, é atividade privativa do enfermeiro:

(A) a verificação de sinais vitais.
(B) a administração de medicamentos por via oral.
(C) a prescrição da assistência de enfermagem.
(D) a realização de curativos simples.
(E) a anotação dos cuidados prestados no prontuário.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – é ação executada por toda a equipe de enfermagem.

B) Incorreta – a administração de medicamentos prescritos é realizada pelo técnico e pelo auxiliar.

C) Correta – a prescrição da assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro.

D) Incorreta – curativos simples são executados pelo técnico e pelo auxiliar.

E) Incorreta – a anotação é dever de todos os profissionais da equipe.

QUESTÃO 02

Segundo a Resolução COFEN nº 736/2024, as cinco etapas do Processo de Enfermagem são:

(A) histórico, diagnóstico médico, prescrição, cuidado e alta.
(B) avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.
(C) anamnese, exame físico, exames complementares, tratamento e prognóstico.
(D) admissão, transferência, alta, óbito e auditoria.
(E) coleta de dados, prescrição médica, execução, supervisão e anotação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o diagnóstico médico não integra o PE.

B) Correta – são as etapas descritas pela Resolução 736/2024.

C) Incorreta – essa é a lógica do raciocínio clínico médico.

D) Incorreta – são momentos da internação, não etapas do PE.

E) Incorreta – a prescrição médica não é etapa do PE.

QUESTÃO 03

Ao perceber que registrou um dado errado na anotação de enfermagem, o técnico deve:

(A) usar corretivo líquido e reescrever.
(B) arrancar a folha e refazer a anotação.
(C) rasurar até tornar o texto ilegível.
(D) utilizar o termo "digo" ou "em tempo" e registrar a informação correta.
(E) deixar como está, pois não é possível corrigir.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – o corretivo é proibido, pois o prontuário é documento legal.

B) Incorreta – retirar folhas do prontuário é infração grave.

C) Incorreta – rasuras comprometem a validade do registro.

D) Correta – "digo" (erro imediato) ou "em tempo" (correção posterior) preservam a legalidade.

E) Incorreta – a correção é possível e necessária.

QUESTÃO 04

Diferencia-se a anotação de enfermagem da evolução de enfermagem porque:

(A) a anotação é privativa do enfermeiro e a evolução é feita por toda a equipe.
(B) a anotação registra dados pontuais e pode ser feita por toda a equipe, enquanto a evolução é análise reflexiva privativa do enfermeiro.
(C) ambas são privativas do técnico em enfermagem.
(D) a evolução é feita somente na alta do paciente.
(E) a anotação dispensa data e horário.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a relação é inversa.

B) Correta – a anotação descreve o que foi observado/feito; a evolução analisa e é privativa do enfermeiro.

C) Incorreta – a evolução é do enfermeiro.

D) Incorreta – a evolução é diária (ou conforme o período definido), não só na alta.

E) Incorreta – data e horário são obrigatórios.

QUESTÃO 05

De acordo com a Resolução COFEN nº 545/2017, ao assinar uma anotação o profissional de enfermagem deve registrar:

(A) apenas o primeiro nome.

(B) o nome, a categoria profissional abreviada e o número de inscrição no COREN, podendo usar carimbo.
(C) somente o número do CPF.
(D) o nome do enfermeiro supervisor no lugar do próprio.
(E) a rubrica sem qualquer identificação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a identificação deve ser completa.

B) Correta – nome, sigla da categoria (Enf., TE, AE) e número de inscrição no COREN.

C) Incorreta – o CPF não substitui a inscrição profissional.

D) Incorreta – cada profissional responde pelos próprios registros.

E) Incorreta – a rubrica isolada não identifica o profissional.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: Lei 7.498/1986 e Decreto 94.406/1987; atividades privativas do enfermeiro; PE em 5 etapas (Res. 736/2024); SAE e taxonomias; anotação × evolução; Res. 545/2017 e 429/2012; boas práticas de registro; admissão, transferência, alta e óbito.

Quadro-resumo: PE = avaliação → diagnóstico → planejamento → implementação → evolução; técnico participa da avaliação e do planejamento e executa a implementação; prontuário por 20 anos.

Pegadinhas: técnico fazendo diagnóstico ou prescrição de enfermagem; citar a 358/2009 como vigente; anotar antes de realizar o cuidado.

Erros comuns: confundir anotação com evolução; usar corretivo; deixar linhas em branco.